

Disturbi dello Spettro Autistico —

Parte 1 · Sintesi

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 08

L'autismo ha una storia piena di errori clamorosi e rivoluzioni tardive. Capire quella storia serve per capire perché ancora oggi circolano tanti miti — e per lavorare bene con le persone nello spettro.

Definizione e basi

- **ASD (Autism Spectrum Disorder)** → sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato
 - Diagnosi basata sull'**osservazione comportamentale**, non su esami biologici
 - Cause: interazione tra fattori **neurobiologici, costituzionali e psicoambientali**
 - Esordio: sintomi presenti **prima dei 3 anni** (diagnosi può avvenire anche in età adulta)
 - Disabilità **permanente**, ma le caratteristiche cambiano nel corso della vita
 - Frase chiave della professoressa: "**L'autismo non si cura, si educa**"
-

Dati epidemiologici

- 1 su 36 bambini negli USA (dato ADDM); 1 su 77 in Italia
 - Circa **80.000 persone** con ASD in Svizzera
 - Anni '70: 4-5 casi su 10.000 → oggi esplosione apparente per: miglioramento diagnostico, ampliamento della definizione, più sensibilizzazione
 - **4 volte più frequente nei maschi** (nelle femmine si maschera meglio)
 - **Intervento precoce** = fattore più determinante per l'evoluzione positiva
-

Storia in sintesi

Anno	Chi	Cosa
1911	Eugen Bleuler	Conia il termine "autismo" (dal greco αὐτός = se stesso)
1943	Leo Kanner	Prima descrizione clinica: "autismo precoce infantile" — 11 bambini
1944	Hans Asperger	Descrive 4 adulti: buone capacità cognitive, deficit nella pragmatica
1955	Kanner (errore)	Ipotesi del disturbo psicogeno: genitori "troppo impegnati"
1960s	Bruno Bettelheim	"Madre frigorifero": autismo come psicosi da mancanza d'amore; bambini tolti alle famiglie
1964	Bernard Rimland	Autismo = disturbo neurologico
1970	Ivar Lovaas	Causa biologica, ABA, intervento precoce
1971	Eric Schopler	I genitori sono competenti, origine organica
1978	Michael Rutter	Non è psicosi, esordio < 3 anni
1979	Wing & Gould	60% con gravi deficit intellettivi — abbatte il mito del genio
1983	Lorna Wing	Definisce la triade e introduce il concetto di spettro
1994	DSM-IV	"Disturbo pervasivo dello sviluppo"
2013	DSM-5	Disturbo dello Spettro Autistico — unica etichetta, 3 livelli di gravità

Falsi miti (da smontare all'esame)

- "Capacità eccezionali sempre" → falso: 60% ha gravi deficit intellettivi
 - "Se vuole capisce / potrebbe parlare" → falso: è un deficit neurologico, non una scelta
 - "È una psicosi" → falso: è un disturbo del neurosviluppo
 - "Si chiude per scelta" → falso: non sa come relazionarsi
 - "I genitori sono la causa" → falso: smentito empiricamente
 - "Non vuole stare con gli altri" → falso: non sa come farlo
-

Diagnosi DSM-5: la diade

A. Deficit persistenti nella comunicazione e interazione sociale (3 criteri):

- **A.1** Deficit della reciprocità socio-emotiva (non risponde al nome, non legge le emozioni altrui) - **A.2** Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali (gesti, contatto visivo, espressioni facciali) - **A.3** Deficit nello sviluppo e gestione delle relazioni (gioco simbolico, amicizie, adattamento ai contesti)

B. Pattern ristretti e ripetitivi (4 criteri): - **B.1** Stereotipie motorie, ecolalia, linguaggio idiosincratico - **B.2** Insistenza nella sameness (routine rigide, stress di fronte ai cambiamenti) - **B.3** Interessi ristretti e fissi, anomali per intensità - **B.4** Iper- o ipo-reattività sensoriale (SIRS / HYPO / HYPER / EP)

Condizioni per la diagnosi: - Sintomi presenti nel **periodo precoce dello sviluppo** - Compromissione **cl clinicamente significativa** del funzionamento quotidiano - Il QI **non è un criterio diagnostico**

I tre livelli di gravità

Livello	Compromissione	Ex-diagnosi
1	Ridotta — richiede supporto	Asperger / alto funzionamento

Livello	Compromissione	Ex-diagnosi
2	Intermedia — richiede supporto sostanziale	—
3	Grave — richiede supporto molto sostanziale	Autismo classico

Specificatori aggiuntivi: con/senza compromissione intellettiva; con/senza compromissione del linguaggio; associata a condizioni mediche o altri disturbi del neurosviluppo.

Neurodiversità e spettro

- **Neurodiversità** (Judith Singer, anni '90): la variazione neurologica è naturale diversità umana, non solo patologia
 - **Spettro** = tre significati: gravità variabile / continuità con la popolazione generale / diversi sottogruppi qualitativi
 - **Regola aurea:** quando hai visto una persona con ASD, hai visto una sola persona con ASD
-

Risorse ticinesi

- **Fondazione ARES** (Giubiasco, dal 1995) → consulenza, formazione, presa in carico, parent-training per famiglie e professionisti
-

Da ricordare: **1) La diagnosi è comportamentale** — si osservano i comportamenti, non si fa un test biologico. **2) La diade DSM-5** — comunicazione sociale + comportamenti ristretti/ripetitivi. **3) L'ambiente conta** — stessa persona, ambienti diversi = sintomi molto diversi. Il lavoro dell'educatore è anche ambientale.